

Colpocleisis جراحة فعالة للغاية وقليلة الإجهاد لعلاج هبوط أعضاء الحوض، وتعمل عن طريق إغلاق معظم قناة المهبل لتثبيت الأعضاء بصفة دائمة. نظرًا لأنها تُغلق المهبل، تُختار من قبل المريضات اللواتي يقطعن بأنهن لا يرغبن في الجماع المهبل في المستقبل. وهي سريعة وخفيفة على الجسم وناجحة جدًا — خيار ممتاز خاصة في الأعمار المتقدمة أو عند وجود مشكلات صحية أخرى.

عن هذه العملية

بدلًا من إعادة بناء الدعم، تعمل هذه الجراحة على إزالة شريط من بطانة المهبل وخياطة الجدارين معًا، مما يُقصر القناة ويُغلقها لمنع هبوط الأعضاء. تُجرى سواء بقي الرحم في مكانه أو بعد إزالته. ولأنها تتجنب إعادة البناء المطولة، فهي أسرع وأقل خطرًا من عمليات هبوط الأعضاء الأخرى، مع معدل نجاح يتجاوز 90%.

القرار الأساسي

النقطة الجوهرية الوحيدة: بعد هذه الجراحة، لن يكون الجماع المهبلي ممكنًا، والتغيير دائم. أما من يقطعن بهذا الاختيار فمعدل رضاهن مرتفع جدًا. سيحرص فريقك الطبي على أن هذا هو الخيار الأنسب وأنه لا توجد مخاوف أخرى (كالحاجة إلى تقييم الرحم) قبل المضي قُدُمًا.

تعلم المصطلحات

هبوط الأعضاء

نزول أعضاء الحوض وتسببها في انتفاخ أو ضغط.

Colpocleisis

جراحة تُغلق معظم قناة المهبل لدعم الأعضاء.

جراحة الإغلاق

إصلاح يُغلق المهبل بدلًا من إعادة بنائه.

LeFort

نوع من Colpocleisis يُجرى مع بقاء الرحم في مكانه.

الحبال (Sling)

دعم يُضاف أحيانًا في الوقت ذاته لعلاج تسرب البول.

هل سيؤلم؟ تُجرى الجراحة تحت التخدير (عادةً شوكي أو عام)، لذا لا تشعرين بشيء أثناءها، وهي قصيرة في الغالب. بعدها، تعاني معظم المريضات من إزعاج خفيف فحسب ويتعافين بسرعة — من أيسر فترات التعافي بين عمليات هبوط الأعضاء.

كيف تستعدّ

بعد الجراحة

- في الغالب في اليوم ذاته أو ليلة واحدة فقط في المستشفى؛ تعافٍ خفيف.
- قسّطرة لفترة قصيرة؛ بعض الإفراز الطبيعي.
- تجنّبي الرفع الثقيل والإجهاد لعدة أسابيع؛ عالجني الإمساك.

- كوني متأكدة تمامًا من قرارك بشأن عدم ممارسة الجماع المهبلي.
- اتبعي تعليمات التخدير (الصيام، وإيقاف مميعات الدم كما يُوصى).
- تقييم ما قبل العملية؛ وأحيانًا يُضاف حيال (Sling) إذا كنتِ تعانيين من تسرّب البول.
- رتّبي وسيلة مواصلات ومساعدة في المنزل.

ما الذي يحدث

اتصلي بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمّى أو قشعريرة
- نزيف غزير
- عدم القدرة على التبوّل بعد إزالة القسّطرة
- ألم حوضي متزايد

1 تكوينين تحت التخدير وتُعطى المضادات الحيوية.

2 تُزال أشرطة من بطانة المهبل وتُخاط الجدران معًا لإغلاق الفتاة.

3 تُوضع قسّطرة وأحيانًا حشوة مهبلية مؤقتة.

ثلاثة أمور تذكّرها

1. Colpocleisis تُغلق معظم المهبل لعلاج الهبوط — سريعة ودائمة جدًا، ومثالية عند الرغبة في إصلاح بسيط وقليل الخطورة.
2. المقايضة دائمة: لن يكون الجماع المهبلي ممكنًا — لذا هي لمن هي متأكدة من هذا القرار.
3. التعافي عادةً سهل. تجنّبي الإجهاد، واتصلي بفريقك عند الحمّى أو النزيف الغزير أو صعوبة التبوّل.